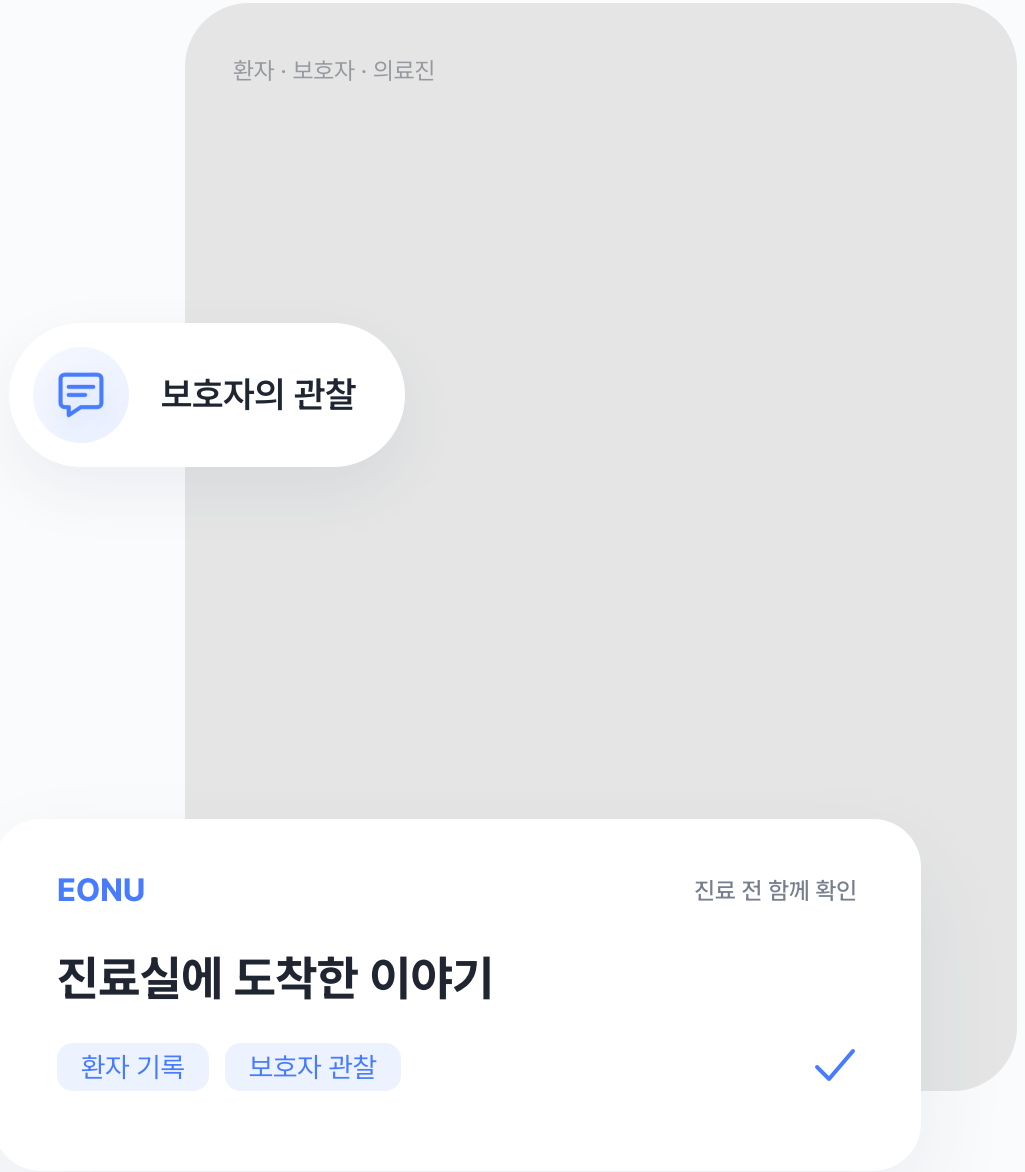
EONU 이어온유

함께 오지 못해도,
이야기는 함께.

환자와 보호자의 일상을
진료에 잇는 AI 소통 솔루션

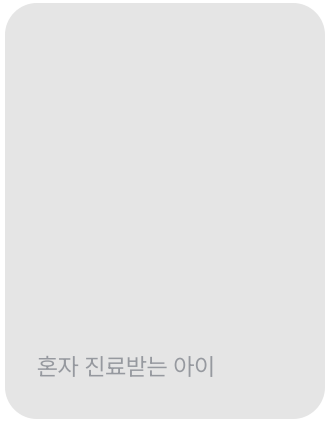


01. 문제

환자는 왔지만, 이야기는 오지 못했습니다.

혼자 진료받는 아이와, 곁에 있지 못한 보호자.

진료실 안



의료진

“언제부터 아팠나요?”

아이

“잘 모르겠어요.”

01 질문은 있지만　　02 설명이 어렵고

진료실 밖



보호자

“전할 이야기가 있는데...”

04 EONU에서

남긴 이야기를 함께 확인

03 지금 곁에 없더라도

설명을 위해 재구성한 사례

세 사람의 이야기, 하나의 흐름으로.

환자의 경험 · 보호자의 관찰 · 의료진의 질문과 계획



서비스가 지향하는 연결 구조

환자의 걱정이, 병원의 상담 기회로.

의료진이 계속 참여할 세 가지 이유. 먼저 수익 기여 가능성을 검증합니다.

01

진료 효율

확인할 내용을
미리 준비

02

임상적 유용성

진료에 필요한
일상의 정보

03 · 초기 검증

수익 기여

걱정에서 시작하는
자발적 상담

미해결 걱정 → 관련 서비스 정보 비급여 포함 → **환자가 상담 선택**

병원이 묻고, 일상에서 답합니다.

질문·서비스 정보·관리 안내를 먼저 설정합니다.

병원마다 다른 질문.
기록의 기준이 됩니다.

안내 QR로 연결된
환자·보호자 화면에서 시작



EONU · 병원 설정

의료진이 정하는
우리 병원의 확인 항목

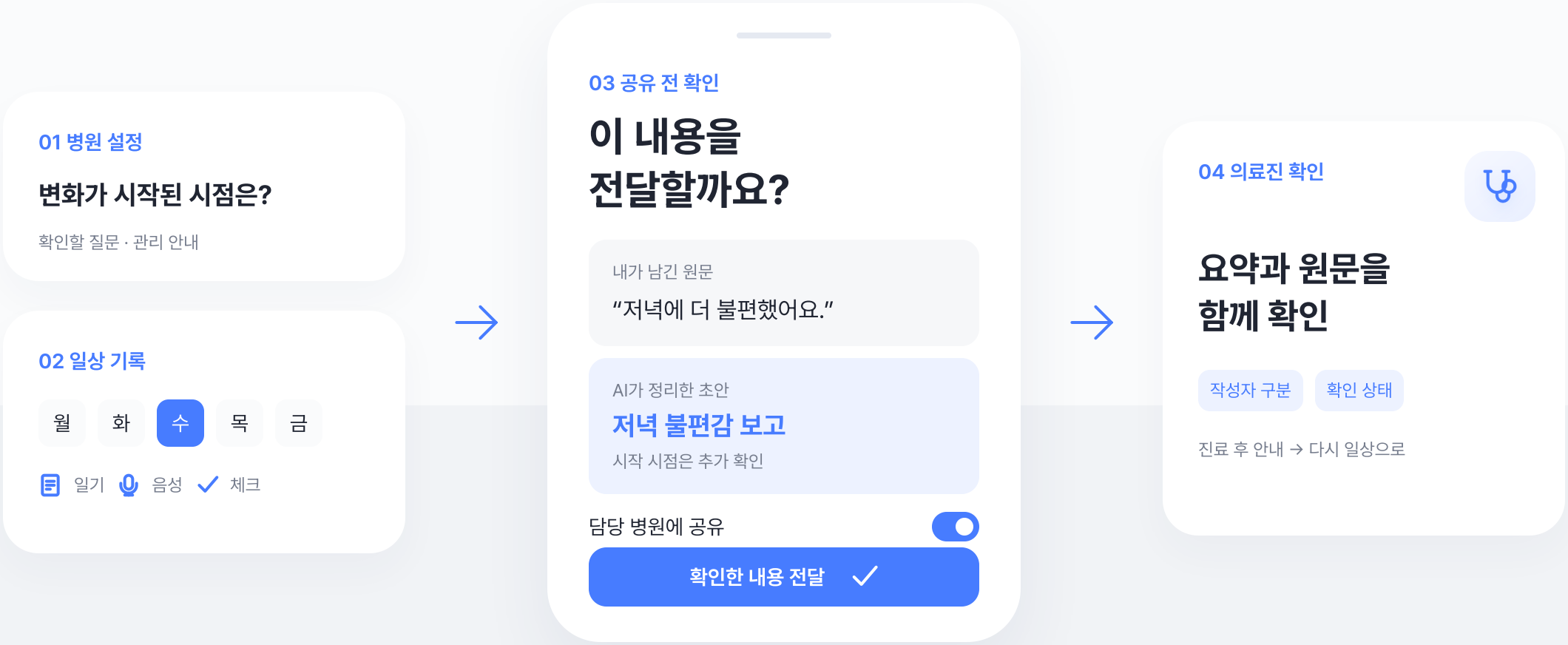
01	**질문** 언제, 어떤 상황에서 불편했나요?	✓
02	**서비스 정보** 관련 상담과 치료 안내	✓
03	**관리 계획** 다음 진료까지 확인할 일	✓

환자 · 보호자

일상에서 기록

기록은 편하게. 전달은 확인하고.

병원 설정 → 일상 기록 → 공유 전 확인 → 의료진 확인



첫 매출의 출발점은 병원 라이선스.

일차의료기관에서 유료 도입을 검증하고, 다음 고객으로 넓힙니다.

먼저 검증

B2B

기관 라이선스

병원이 구매하고,
환자·보호자가 연결됩니다.

기관 단위 반복 이용료

도입 이후 확장

B2B2C

환자·보호자의 추가 유료 가치

별도 구매 경로

B2G

공공 구매기관 · 예산 · 조달 검증

검토 → 제한 실증 → 유료 제안 → 계약

큰 시장에서, 먼저 살 고객을 좁힙니다.

현재 판매할 소프트웨어를 기준으로 TAM · SAM · SOM을 구분합니다.



현재의 핵심 · B2B

기관 수 × 연간 라이선스

매출 상한과 실제 확보 목표를 분리

B2B2C	이용자 × 유료 전환율 × 연간 이용액
B2G	구매사업 수 × 계약 단가

중복 계약 · 연구지원금 · 미래 기기 매출 제외

범위와 산식 개념도 · 면적은 금액에 비례하지 않으며 시장 수치·가격은 산정 전

일상 기록에서, 연결된 건강 정보로.

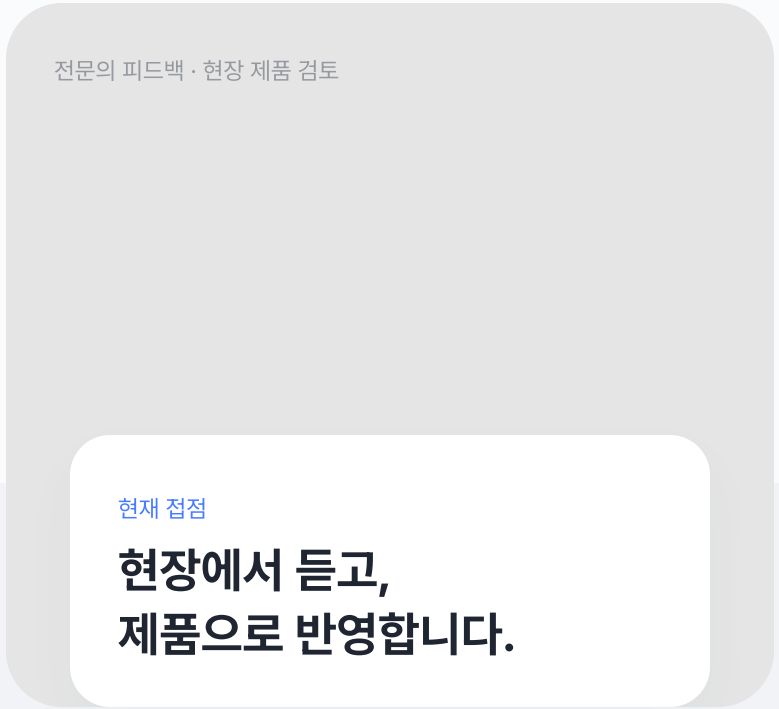
병원 도입 검증 이후, 정보의 임상적 유용성과 입력 부담을 확인합니다.



확장 방향 · EMR·외부 앱·기기 연동 및 바이오마커는 후속 검토·연구

현장 피드백을, 첫 도입으로.

질문과 템플릿, 제품에 반영할 운영 경험을 모으고 있습니다.



현재 접점

**현장에서 듣고,
제품으로 반영합니다.**

정신과 전문의
지속적인 피드백

의료혁신 연구소
기관 접점

청년 우울증 프로젝트
의료봉사 참여 확정 기재

다음 검증 **실제 활용** · **업무 부담** · **지불 의사**

1억 원, 첫 유료 모델을 향한 실행 자금.

의료·AI 이해를 바탕으로 직접 기획하고, 개발하고, 수정합니다.

USE OF FUNDS

1 억 원

대표 사진

직접 만드는 실행력

기획 → 개발 → 수정

01 제품

사용할 수 있게

개발 · 보안 · 운영

02 실증

쓸 이유를 확인

의료진 확인 · 현장 운영

03 고객 확보

첫 유료 계약으로

소개 · 방문 데모 · 파일럿

사용계획 총액 · 세부 배분·기간·목표는 확정 전

EONU 이어온유

환자에게 필요한 연결.
병원도 계속 쓸 이유.

일상의 이야기를 진료로,
진료의 계획을 일상으로.

첫 병원군과 함께, 가치를 검증하겠습니다.

환자 · 보호자 · 의료진의 일상



이어온유 연락처 [확인 후 입력]